TUMORES DE INTESTINO DELGADO

DRA. STEPHANY TORRES

EPIDEMIOLOGÍA GENERAL

- Representan menos del 5% de los tumores digestivos, pese a que el intestino delgado constituye el 75% de la longitud del tubo digestivo.
- Baja incidencia relativa por tránsito rápido, menor exposición a carcínogenos luminales y menor flora bacteriana.

ADENOCARCINOMA DUODENAL

- Predilección por la 2a porción del duodeno (cerca de la ampolla de Vater).
- Clínica: obstrucción, ictericia (si compromete la ampolla), sangrado oculto.
- Tratamiento: pancreatoduodenectomía (Whipple) en tumores de la 2a porción; resección segmentaria en 3a/4a porción.

TUMORES NEUROENDOCRINOS (CARCINOIDES)

- Más frecuentes en íleon; pueden producir serotonina y otras aminas. Síndrome carcinoide ocurre principalmente con metástasis hepáticas.

TUMOR DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL (GIST)

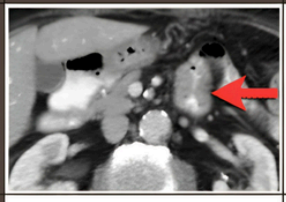
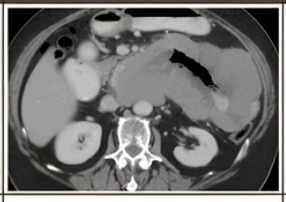
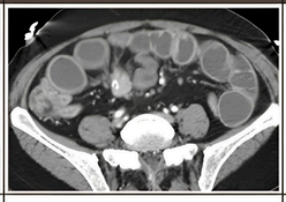
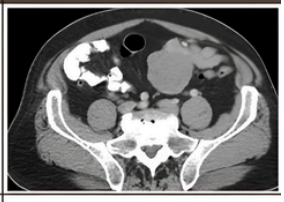
- Se origina de las células intersticiales de Cajal.
- Sobreexpresa c-KIT (CD117), confirmado por inmunohistoquímica.
- No requiere linfadenectomía extensa (diseminación hematógena, no linfática); responde a imatinib en casos avanzados o irresecables.

LINFOMA DE INTESTINO DELGADO

- Tipos más frecuentes: linfoma MALT y linfoma difuso de células B grandes.
- Predilección por el íleon distal (mayor tejido linfoide asociado al intestino).
- Puede presentarse con obstrucción, perforación o sangrado.

MANIFESTACIONES Y DIAGNÓSTICO

- Clínica inespecífica, dx tardío. Herramientas: enteroscopia, cápsula endoscópica, TC/RM con enterografía. Obstrucción/invaginación en adulto debe hacer sospechar tumor.

	Adenocarcinoma	Lymphoma	Carcinoid	GIST
				
Risk factors	HNPCC Familial adenomatous polyposis Peutz-Jeghers Celiac disease. Crohn's disease	Celiac disease Crohn's disease, SLE Immunocompromised state Post-Chemotherapy Extra-intestinal lymphoma		
Location	Duodenum > Jejunum > ileum	Terminal ileum	Distal ileum appendix	Stomach >> Small bowel
Key feature	Focal circumferential mass with shouldered borders	Thick walled infiltrating mass with aneurysmal dilatation	Transmural hypervascular mass Mesenteric mass with Ca++ Desmoplastic reaction Bowel wall thickening.	Well defined exophytic mass
Enhance-ment	Moderate and heterogeneous	Homogeneous	Hypervascular	Heterogeneous
Associated features		Splenomegaly Mesenteric and retroperitoneal lymphadenopathy	Carcinoid syndrome (<10 %) Liver metastases	Hypervascular liver metastases. No lymph node metastases. Mesenteric metastases often in recurrent disease
Diff. Diagn.	Large lymphoma	Large adenocarcinoma	Sclerosing mesenteritis	Lymphoma